

QE Les œdèmes _ Dr Anoun

FMS 15/7/2025

1. **Cocher les bonnes réponses concernant la physiopathologie des œdèmes :**
 - a. Leur présence traduit la séquestration d'eau et de sodium dans le secteur interstitiel du compartiment intracellulaire.
 - b. Ils apparaissent lorsqu'il y a une augmentation du liquide interstitiel d'au moins 40%
 - c. Ils peuvent être localisés ou généralisés
 - d. Ils peuvent être limités au niveau d'une séreuse
 - e. Ils peuvent être associés à une infiltration sous-cutanée en cas d'anasarque
2. **Cocher les bonnes réponses concernant les propriétés du milieu interstitiel :**
 - a. Il représente 75% du milieu extra-cellulaire
 - b. Ses échanges avec le milieu intravasculaire se font selon la loi de Sterling
 - c. Sa teneur en sodium est plus importante que celle du milieu intracellulaire
 - d. Il constitue le siège d'échanges permanents avec le secteur lymphatique
 - e. Il est drainé par les vaisseaux lymphatiques
3. **Cocher les bonnes réponses concernant les mécanismes des œdèmes :**
 - a. Ils peuvent être dus à une augmentation du débit lymphatique
 - b. La saturation du système lymphatique entraîne l'apparition d'œdèmes
 - c. L'augmentation de la pression oncotique peut entraîner l'apparition des œdèmes
 - d. La rétention de sodium et d'eau par les reins seule ne donne pas d'œdèmes
 - e. L'augmentation de la pression hydrostatique peut être responsable de l'apparition d'œdèmes localisés
4. **Un œdème des 2 membres inférieurs peut être dû à :**
 - a. La diminution de la pression hydrostatique dans le pôle artériolaire des capillaires
 - b. L'augmentation de la pression oncotique plasmatique
 - c. L'augmentation de la pression hydrostatique capillaire
 - d. L'augmentation de la perméabilité capillaire
 - e. Un dysfonctionnement des vaisseaux lymphatiques
5. **Cocher les bonnes réponses concernant l'équilibre de Starling :**
 - a. Il régit les échanges entre les milieux intracellulaire et interstitiel
 - b. Il conditionne les échanges capillaires
 - c. Est conditionné par la pression de perméabilité capillaire et la pression de filtration
 - d. Un gradient de pression positif favorise l'entrée d'eau dans les capillaires
 - e. La pression oncotique permet de retenir l'eau au niveau des capillaires
6. **Quelle est la principale force responsable de la formation des œdèmes ?**
 - a. La pression hydrostatique capillaire
 - b. La pression oncotique plasmatique
 - c. La perméabilité capillaire
 - d. L'obstruction du retour veineux
 - e. Le débit lymphatique
7. **Les œdèmes par augmentation de la perméabilité capillaire peuvent être dus à :**
 - a. Un œdème angio-neurotique
 - b. Une piqûre d'insecte

- c. Une thrombophlébite
 - d. Une prise de corticoïdes à fortes doses
 - e. Une rétention hydrosodée
8. **Cocher les bonnes réponses concernant les mécanismes des œdèmes:**
- a. La perturbation de l'équilibre de Starling aboutit à la formation d'œdèmes
 - b. Le système lymphatique récupère l'eau qui transsude des capillaires
 - c. Le système lymphatique récupère les protéines qui s'exfiltrent des capillaires
 - d. L'albumine retient l'eau au niveau du milieu interstitiel
 - e. Le gradient de pression négatif au pôle artériel favorise le retour vers le capillaire
9. **Quelles étiologies entraînent une diminution de la pression oncotique ?**
- a. L'insuffisance rénale chronique
 - b. Les entéropathies exsudatives
 - c. Les brûlures étendues
 - d. L'insuffisance cardiaque globale
 - e. L'insuffisance hépatocellulaire
10. **Au cours des œdèmes localisés :**
- a. Il existe un excès de liquide dans un territoire du secteur interstitiel
 - b. Une rétention hydrosodée est souvent présente
 - c. Il existe une diminution de la pression oncotique
 - d. Les systèmes natriurétiques sont souvent mis en jeu
 - e. Le mécanisme causal peut être d'origine lymphatique
11. **La physiopathologie des œdèmes fait intervenir une stase veineuse dans les cas suivants :**
- a. Une thrombophlébite
 - b. Une prise d'AINS
 - c. Un alitement
 - d. Un érysipèle
 - e. Une insuffisance rénale chronique terminale
12. **Les mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans la constitution de l'œdème au cours de la thrombophlébite sont les suivants :**
- a. Une stase lymphatique
 - b. Une rétention hydro-sodée
 - c. Un obstacle au retour veineux
 - d. Une inflammation de la paroi vasculaire
 - e. Une inondation capillaire par hyper débit
13. **Les signes cliniques pouvant révéler la présence d'un œdème sont :**
- a. Une bouffissure du visage
 - b. Des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire
 - c. Une insuffisance respiratoire aiguë
 - d. Un signe de flot positif
 - e. Un signe de Harzer positif
14. **L'œdème de type lymphatique :**
- a. Donne un aspect de peau d'orange
 - b. Est de consistance ferme
 - c. Peut être généralisé
 - d. Est constant d'emblée sur le nycthémère
 - e. Donne un signe de Homans positif
15. **Pour évaluer le retentissement d'un œdème, il faut :**
- a. Quantifier la diurèse

- b. Prendre la saturation en oxygène (SaO₂)
 - c. Comparer le poids actuel du patient à son poids antérieur
 - d. Rechercher un souffle à l'auscultation cardiaque
 - e. Vérifier les pouls d'un membre affecté par une thrombose veineuse
16. Les circonstances de découverte d'un œdème peuvent être :
- a. Un prurit généralisé
 - b. Un microvoltage sur l'ECG
 - c. Une hypoxie
 - d. Un trouble de la conscience
 - e. Une altération de l'état général

Cas cliniques QCM

Cas clinique 1 :

Une patiente âgée de 65 ans, se présente avec des **œdèmes des 2 membres inférieurs**. Elle a comme antécédents médicaux :

- HTA depuis 10 ans, bien contrôlée sous Amlodipine
- DNID depuis 5 ans (régime alimentaire + metformine)
- Une insuffisance cardiaque congestive diagnostiquée il y a 3 ans, traitée par des diurétiques.

À l'examen clinique :

- Pression artérielle = 150/90 mmHg.
- Pouls : 88 battements par minute, régulier.
- Œdèmes bilatéraux des membres inférieurs blancs, mous, gardant le godet arrivant jusqu'aux genoux.
- Signe de Homans négatif
- Auscultation cardiaque : souffle systolique au foyer mitral.
- Auscultation pulmonaire normale.
- Pas d'autres anomalies majeures à l'examen.

Sur la base de ces informations, veuillez répondre aux questions suivantes :

- 1) **Quels mécanismes peuvent être incriminés dans l'apparition des œdèmes chez cette patiente ?**
- a. Insuffisance cardiaque
 - b. Insuffisance rénale aiguë
 - c. Néphropathie glomérulaire
 - d. Thrombose veineuse profonde
 - e. Prise d'amlodipine

- 2) **Quelles sont les causes de l'œdème au cours de la néphropathie glomérulaire ?**
- a. Augmentation de la clairance rénale
 - b. Diminution de la pression oncotique
 - c. Diminution de l'osmolarité plasmatique
 - d. Augmentation de la pression hydrostatique
 - e. Fuite rénale de sodium
- 3) **Quelles est la cause de l'œdème dû à la prise d'amlodipine ?**
- a. Une Diminution de la réabsorption lymphatique
 - b. Une diminution de la clairance rénale
 - c. Une diminution de la pression oncotique
 - d. Une augmentation de la pression hydrostatique
 - e. Une hyper-perméabilité capillaire
- 4) **Quels examens complémentaires doit-on demander pour étayer le diagnostic étiologique des œdèmes chez cette patiente ?**
- a. Electrocardiogramme
 - b. Radiographie thoracique
 - c. Echographie cardiaque
 - d. Protéinurie de 24h
 - e. Echographie rénale

Cas clinique 2 :

Un patient âgé de 75 ans se présente pour gonflement des jambes et une prise de poids récente. A l'examen physique, vous constatez un œdème bilatéral des membres inférieurs, une turgescence des veines jugulaires et des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire. Le reste de l'examen était sans anomalies.

Le patient a comme antécédents un syndrome métabolique avec HTA, dyslipidémie et Diabète compliqué d'une cardiopathie ischémique.

1. **Quel est le mécanisme physiopathologique le plus probable de l'œdème observé chez ce patient ?**
- a. Une augmentation de la perméabilité capillaire
 - b. Une diminution de la filtration lymphatique
 - c. Une inondation du lit capillaire
 - d. Augmentation de la pression hydrostatique
 - e. Diminution de la pression oncotique
2. **Quelle est la principale cause de l'œdème chez ce patient ?**
- a. Une insuffisance cardiaque gauche
 - b. Une HTAP pré-capillaire
 - c. Une insuffisance cardiaque congestive
 - d. Une insuffisance rénale
 - e. Une insuffisance lymphatique

3. **Quel est le mécanisme physiopathologique responsable des râles crépitants entendus à l'auscultation pulmonaire chez ce patient ?**
 - a. Un infiltrat cellulaire pulmonaire
 - b. Un bronchospasme
 - c. Un œdème interstitiel pulmonaire
 - d. Un épanchement pleural
 - e. Une obstruction artériolaire pulmonaire
4. **Quelles seraient les caractéristiques cliniques de l'œdème des membres inférieurs chez ce patient ?**
 - a. Blanc
 - b. De consistance dure
 - c. Gardant le godet
 - d. Douloureux
 - e. Déclive

Cas clinique 3 :

Madame D., 68 ans, consulte pour un **œdème unilatéral du membre inférieur gauche** apparu progressivement depuis 5 jours. Elle se plaint également de **douleur modérée**, surtout en position debout, et d'une sensation de tension dans la jambe. Elle n'a pas noté de fièvre ni de dyspnée.

- **Antécédents :**
 - HTA bien contrôlée sous inhibiteur calcique
 - Varices connues, non opérées
 - Intervention pour fracture du poignet gauche il y a 3 semaines (plâtre retiré il y a 10 jours)
 - **Examen clinique :**
 - TA = 130/80 mmHg, FC = 84 bpm
 - Œdème localisé au membre inférieur gauche, mou, ne prenant pas le godet, remontant jusqu'à la cuisse
 - Jambe gauche légèrement plus chaude que la droite, discrète érythrose
 - Circonférence du mollet gauche : 3 cm de plus que le droit
 - Signe de Homans douteux
 - Pas d'atteinte du membre inférieur droit
 - Reste de l'examen : RAS
1. **Quelles sont les étiologies les plus probables à évoquer devant cet œdème unilatéral ?**
 - a. Thrombose veineuse profonde
 - b. Insuffisance cardiaque droite
 - c. Lymphœdème secondaire
 - d. Traumatisme local

- e. Œdème médicamenteux

2. Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers une thrombose veineuse profonde ?

- a. Asymétrie de circonférence des mollets
- b. Œdème unilatéral à début aigu
- c. Douleur provoquée à la dorsiflexion du pied
- d. Érythrose et chaleur du membre atteint
- e. Prise récente d'un inhibiteur calcique

3. Parmi les examens suivants, lequel(s) permet(tent) de confirmer le diagnostic de thrombose veineuse profonde ?

- a. Échodoppler veineux des membres inférieurs
- b. Dosage des D-dimères
- c. Angioscanner thoracique
- d. Scintigraphie osseuse
- e. Échographie cardiaque

4. Quelles caractéristiques seraient plus évocatrices d'un lymphœdème ?

- a. Œdème dur, non prenant le godet
- b. Apparition rapide en quelques heures
- c. Atteinte bilatérale symétrique
- d. Présence de godet profond
- e. Antécédent de chirurgie ganglionnaire ou radiothérapie